

色阳性。翻开上睑,见中央穹窿深部覆盖苔,擦除脓性分泌物,其下有一 $3 \times 1.5\text{mm}$ 半透明淡棕色昆虫翅膀粘附结膜上,当即取出,以抗生素液冲洗结膜囊并滴眼,一周后结膜充血消退,角膜荧光素染色阴性。

讨论

穹窿结膜为球结膜和睑结膜移行部分,此处结膜松弛且多皱折,以利于眼球活动。当异物进入结膜囊后,随患者感觉不适以手揉眼,偶将异物推移至穹窿深部或由于反复揉眼将锐利异物刺入柔软穹窿结膜内,如例2、例3。此外,有些异物具有粘附性,移入穹窿部后可较长时间滞留,如例4之昆虫翅膀异物。而麦芒进入结膜囊后,如果刺入角膜、球结膜或下穹窿则较易发现取出,而当随揉眼使麦芒进入上穹窿结膜后,可出现频繁瞬目、眼睑痉挛,更加促进麦芒向穹窿深部移动,并

刺入柔软的结膜组织内。由于异物滞留,造成创伤、污染而引起上睑充血、肿胀,致使检查困难,临床上往往仅根据眼睑、结膜充血、水肿按炎症处理而漏诊异物。因此,对外眼炎症患者应认真追问病史,对有眼部外伤及异物接触史者应作外眼全方位详细检查。尤其对主诉不清的婴幼儿患者,当结膜囊有大量脓性分泌物,经用抗生素治疗无效,角膜、前房未见病变而又有别于一般的结膜炎及脓漏症时,即应考虑有结膜囊异物存在的可能,应仔细检查穹窿部,尤其上穹窿部。应在表面麻醉下首先解除眼睑痉挛,然后用睑拉钩协助翻开上睑,并轻向眼球方向加压眼球,充分暴露穹窿深部寻找异物,从而及时确诊与治疗。

(收稿 1995-12-29)

130-131 颌面部韧带状瘤;误诊分析 (26)
颌面部韧带状瘤 10 例误诊分析 R739.8/0.4
贵州省人民医院[550002] 陈燕 赵桂香 杨威*

韧带状瘤(Desmoid tumor)又称肌-腱膜纤维瘤^[1]、侵袭性纤维瘤病^[2]等,在颌面外科罕见,常易误诊。现将我们误诊的10例分析如下。

临床资料

男性4例,女性6例;年龄6~32岁,平均22岁;病程最短1月,最长7年。

一、症状体征 瘤体在颌面部软组织内6例,生长较慢,无疼痛及不适,肿瘤呈橡皮样条索或肿块,条索的长轴与肌束方向一致,活动性差。其中4例有外伤史,肿瘤与皮肤瘢痕组织粘连。2例无外伤史,发生于鼻侧,与皮肤无粘连。发生于颌骨内4例,其中上颌骨1例,下颌骨3例。局部均有肿胀、疼痛或压痛,术前均有患部牙痛史,其中1例引起牙齿松动。X线表现:病变区表现为界限清楚的透光区,呈单房或多房骨破坏,内有骨间隔,无骨化和钙化致密影像,边缘不规则,骨皮质膨胀变薄,周围可有硬化缘,或骨皮质破坏不连续。

二、病理学表现 肿物由增生活跃的成熟性纤维组织构成,增生的纤维母细胞和胶原束呈波浪状交错编织,增生的纤维组织常侵及周围肌肉组织,肌纤维分隔成小岛并呈萎缩变性,血管较少,在肿块周边可见灶性淋巴细胞浸润。

三、误诊疾病 误诊为瘢痕疙瘩及瘢痕组织增生4例,皮肤纤维瘤2例,颌骨恶性肿瘤3例,造釉细胞瘤1例。

【病例】女,20岁。因左上颌磨牙疼痛、松动,面部肿胀,在当地医院按炎症治疗,无效。左侧面部逐渐膨隆,左眼球突出。X线示左上颌窦透光不良,外侧骨壁呈膨胀性破坏。临床诊断:左上颌骨恶性肿瘤。行左上颌骨扩大切除术。术中见肿物充满上颌窦腔,上颌窦前壁及眶底骨破坏,肿物突出窦腔侵犯周围组织。肿物为实质性,无包膜,质地硬韧,切面见灰白色呈编织状纤维束。病理诊断:骨韧带状纤维瘤。术后放疗,随访5年无复发。

讨论

本组病例特点:①90%以上发生在30岁以下青年,多在20岁左右;②易复发。本组3例曾在当地医院手术,术后未做病理检查,因复发再次就诊;③与外伤有关。本组6例软组织韧带状瘤,其中4例有外伤史;④具有较强的局部浸润性和破坏性。本组4例颌骨韧带状瘤患者均有程度不同的骨破坏,严重者穿破骨壁,侵及周围软组织,引起功能障碍。

韧带状瘤临床并非罕见,以腹壁及长骨干骺端多见,发生在颌面部甚少。本组引起误诊的主要原因:①接诊医生对本病的认识不足,加之多有外伤史,肿物与瘢痕组织粘连,易误诊为瘢痕组织增生、瘢痕疙瘩。术后又忽视病理检查,造成复发;②肿物具浸润性,根据临床表现及X线片所见常易误诊为恶性肿瘤,甚至术

* 贵阳市口腔医院

中直视下也易疑为恶性病变。故当术中初次冰冻切片报告为良性病变时,医生常有怀疑而第二次取材送检。本文4例颌骨韧带状瘤患者,有2例术中作2次冰冻切片检查,延长了手术时间。

颌面部软组织肿物,如有质坚如橡皮、沿肌纤维方向分布、边界不清、活动度差等特征者应考虑为韧带状

瘤。侵及颌骨的韧带状瘤应注意和恶性肿瘤鉴别。确定诊断主要靠组织学检查。术中见到边缘不清、较硬的纤维肿物内含肌腱纤维束时,应考虑为韧带状瘤。一旦确诊,术后应放疗,避免复发。

(收稿 1996-1-29 修回 1996-4-17)

131-132 嗅神经母细胞瘤, 误诊, 分析 嗅神经母细胞瘤四例误诊报告

27
R739.604

山东省胜利石油管理局中心医院[257034]

王炳平 吴学辉 刘正华 陆秉勋

嗅神经母细胞瘤是鼻腔上份的嗅神经上皮细胞发生的极少见的恶性肿瘤,临床易误诊。本文报告4例误诊病例,结合文献就其诊断和误诊原因分析如下。

病例报告

【例1】男,4岁,鼻衄反复发作1年,曾多处就医均未明确诊断。1个月前出现左眼球进行性外突,于1990年3月2日来我院就诊,检查发现左眼球及内眦部明显外突,球结膜充血。左鼻腔内紫红色肿物,触之易出血。活检病理诊断为嗅神经母细胞瘤。CT检查见病变侵占左鼻腔、筛窦、左上颌窦和左球后,颅底骨、左眶内板骨质破坏。行单纯放疗,随访5年健在。

【例2】男,61岁。因嗅觉减退伴流黄色鼻涕、左鼻塞半年,于1990年5月4日在外院诊断为鼻息肉而行手术切除。术后半年又出现右鼻塞,嗅觉继续减退,至1991年4月来我院就诊。检查发现右鼻腔顶外侧有一息肉样肿物,中等硬。取活检,病理报告为嗅神经母细胞瘤。经右侧鼻切开行肿瘤切除术,术后给予放疗,随访4年健在。

【例3】男,22岁。左眼剧烈胀痛,视力进行性下降,左眼球突出2个月,头痛、恶心、呕吐半个月,于1994年5月在外院行MRI检查,示前颅凹有一肿物约10×6×6cm,累及左眼眶、左上颌窦内壁、筛窦及左鼻腔。诊为颅内肿瘤。于1994年5月19日行开颅肿瘤部分切除术,术中见肿瘤位于额极硬膜外,浸润颅底及左眶壁、左上颌窦内壁、筛窦。术后病理为颅底骨肿瘤。来我院病理科会诊,行免疫组化检查确诊为嗅神经母细胞瘤。术后给予放疗,半年后死于颅内肿瘤复发。

【例4】男,42岁。右侧鼻塞半年,鼻衄2个月,于1995年1月12日来我院就诊,检查发现右鼻腔内肿物,呈浅红色,触之易出血,诊为鼻息肉,于1995年1月19日行手术治疗。术中见右侧筛窦、右上颌窦均受侵。

术后病理诊断为嗅神经母细胞瘤,术后CT发现右蝶窦内仍有软组织影,术后行放疗,随访半年健在。

讨论

一、嗅神经母细胞瘤的诊断 嗅神经母细胞瘤约占鼻腔肿瘤的3%^[1],可发生于任何年龄,11~20岁和50~60岁两个年龄段为发病高峰,性别无明显差异。此瘤为低度恶性,生长缓慢,但部分病例发展也可非常迅猛^[2],例3即如此,病史只有2个月,肿瘤侵犯已相当广泛。其生物学行为主要表现为侵犯周围窦腔、颅腔及脑组织的倾向;颈部淋巴结转移少见。约10%~30%的病人发生远隔转移^[2]。嗅神经母细胞瘤临床上无特异性,早期较隐匿,多有鼻塞、鼻衄,有的病人伴有嗅觉减退。部分病人较早出现眼部症状,如眼痛、视力降低、眼球突出等,如例1、例3,此为肿瘤侵犯眶壁及球后所致,临床易误诊为眼科疾病。当肿瘤进一步发展侵犯颅底进入颅内时可出现头痛、恶心、呕吐等症状。临床检查早期鼻腔内可发现浅红色、质中的息肉样肿物。部分肿瘤呈结节状,触之易出血,当肿瘤进一步发展侵入相邻组织器官时,可出现相应的临床体征。有淋巴结转移时颈部可触及肿大的淋巴结。CT和MRI检查可明确肿瘤的部位和侵犯范围。确诊需活检行病理学检查。文献报道光镜下Homer-Wright及Flener菊形团和瘤细胞之间的嗜酸性纤维背景是嗅神经母细胞瘤有诊断意义的特征,但绝非所有的病例中都能见到,故对常规病理学诊断困难者应行特殊染色、电镜检查或免疫组化检查以明确诊断^[3]。

二、误诊原因分析

1. 本病罕见,又无特异性表现,临床医师对本病缺乏认识和警惕。

2. 采集病史不全面,体格检查不细致。尽管病人的第一主诉不同(鼻塞、眼突、头痛等),而首先就诊于不